

Préparation au RESCOS et status cliniques

Introduction au document :

Ce document donne des conseils pour l'entretien clinique et résume les différents status cliniques qu'un médecin doit savoir maîtriser. Il est important de noter que ce **n'est pas** un document officiel de l'école de médecine de Lausanne, et n'a donc **pas** valeur de référence.

Suggestions pour se préparer à l'examen ECOS :

Un poste à l'ECOS de MMed2 et de l'ECOS fédéral se compose typiquement (mais pas toujours) de quatre parties :

1. Anamnèse
2. Status
3. Management
4. Conclusion de l'entretien

1. Anamnèse :

Une anamnèse « typique » comporte au moins les catégories suivantes :

1. **Anamnèse actuelle** : « qu'est-ce qui vous amène ? » suivi de questions permettant de cerner au mieux la plainte *actuelle* du patient. Y rajouter les *maladies actuelles* que le patient pourrait avoir et leur prise en charge.
2. **Anamnèse par système** : toucher tous les systèmes du corps et poser des questions en rapport. Pratiquement, on peut établir une liste de « grandes » questions, et s'enfoncer dans plus de détails si on remarque un aspect anormal. Faire un résumé exhaustif de l'anamnèse par système dans ce résumé n'est pas judicieux, car le but n'est pas d'apprendre une liste par cœur et de la ressortir à toutes les sauces. Mais vous pouvez partir sur la base suivante :
 - a. Général : sudations nocturnes ? Fatigue ? Frissons ? Fièvre ?
 - b. Neuro-psy : céphalées ? Vertiges/troubles de l'équilibre ? Problème de coordination ? Problème de vue/ouïe/goût/odorat ? Humeur ? Mémoire ?
 - c. Cardiovasculaire : fatigue anormale à l'effort ? Palpitations ? Douleurs ?
 - d. Pulmonaire : peine à respirer ? Crachats (et couleur) ? Toux ?
 - e. Digestive : appétit ? nausées/vomissements ? Fréquence, couleur et consistances des selles ?
 - f. Urinaire : fréquence et couleur des urines ? Démangeaisons / douleurs ?
 - g. Génitale/sexuelle : fréquence et intensité des règles ? Comportement sexuel à risque ? Démangeaisons/éruptions ?
 - h. Ostéo-articulaire : douleurs ? Troubles de la marche ? Mouvements limités ? Instabilités ?
 - i. Dermatologique : tâches / boutons nouveaux ou ayant évolué ? Démangeaisons ? Rougeurs ?

➔ En pratique clinique, on ne peut pas être exhaustif, mais poser au moins 1-2 questions par système est important.
3. **Histoire médicale / antécédents** : maladies, opérations, hospitalisations, allergies, vaccins, maladies d'enfance.
4. **Habitudes** : médicaments, alcool, tabac, drogues, sport, sommeil, sexualité, spiritualité.
➔ **Mnémotechnique 3+4** : MOMA = **M**aladies, **O**érations, **M**édicaments, **A**llergies
5. **Anamnèse familiale** : parents, grands-parents, enfants, fratrie.
6. **Résumés** : aussi souvent que nécessaire et au moins une fois avant de conclure l'entretien.

Dans la pratique, chacun mène son anamnèse comme il l'entend et doit être capable de la modifier selon les circonstances. Il est impossible et peu judicieux de poser toujours toutes les questions, mais une certaine **systématique** est essentielle.

Toute anamnèse, que ce soit à l'ECOS ou dans la clinique doit être **la plus complète possible**. Il faut donc non seulement bien cerner la plainte, mais aussi poser certaines questions systématiquement (antécédents, allergies, médicaments, habitudes etc.). Le risque, si vous n'êtes pas systématiques, autant à l'ECOS qu'en clinique est de vous **enfoncer dans un tunnel diagnostique** et ne poser des questions qu'en rapport avec le diagnostic présumé que vous avez.

C'est dangereux pour plusieurs raisons :

- Un patient peut avoir **plusieurs problèmes** (une appendicite et un problème de cœur et une dépression, et etc.). Vous n'avez qu'à voir les listes des problèmes des patients en médecine interne pour vous rendre compte que dans la vie réelle, un patient avec un seul problème est assez rare. A l'ECOS, comme dans la vie, quelqu'un peut très bien se présenter avec un début de démence et en parallèle faire une insuffisance rénale terminale. Si vous oubliez d'être systématiques vous passerez souvent à côté de diagnostics qui peuvent être capitaux.
- Si votre anamnèse n'est pas systématique, vous risquez **d'oublier** des questions importantes, comme les allergies. Tuer quelqu'un qui est allergique à l'aspirine parce qu'on ne lui a pas posé la question, c'est plus ou moins mettre un terme à votre carrière clinique et vivre avec des années de regrets. **Vos oublis ont des conséquences bien réelles**. Personne n'est parfait, mais systématiser vos questions d'anamnèse permet de grandement limiter les oublis. Entraînez-vous en conséquence !

En bref, plus votre anamnèse est systématique, moins vous avez de chance de passer à côté d'aspects importants et plus ce sera facile pour vous ! Avec le temps, vous engrangerez assez d'expérience pour savoir quelles circonstances amènent à poser quelles questions, mais entre temps, si vous voulez être un médecin assistant efficace (et surtout non-dangereux) n'hésitez pas à demander *plus que pas assez*.

Bien que systématique, votre anamnèse ne doit pas non plus ressembler à une liste « apprise par cœur ». Il faut être **systématique mais pas automatique**. Par exemple, demander à une femme de 92 ans la fréquence de ses règles démontre une non-compréhension du corps humain (et la patiente risque de vous regarder bizarrement). En parallèle, il ne faut pas non plus ne pas poser une question car elle vous « gêne » ou parce que des préjugés sociaux vous font penser que ce n'est pas relevant. Le cas le plus typique pour illustrer cet aspect est l'incidence et la prévalence de MST dans les EMS ; loin d'être négligeable, elle prouve que ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on ne peut pas avoir un comportement sexuel à risque !

L'art de l'anamnèse bien faite est donc une **bonne systématique**, contrebalancée par un **bon raisonnement clinique** qui permet de cibler les questions essentielles et **d'éviter l'automatisme**.

2. Status cliniques : à l'inverse de l'anamnèse, et surtout dans une situation ECOS où vous n'avez pas beaucoup de temps (mais cela arrive aussi souvent en clinique), les status doivent être **ciblés**. On ne va pas faire tous les status à quelqu'un qui se présente pour une fracture du poignet. On n'a pas le temps de faire un status neurologique complet à toute personne qui se présente avec un trouble de l'équilibre, avec touché-piqué sur tout le corps, test calorique et tutti quanti.

Les règles qui font sens sont :

1. *N'effectuez que les status qui semblent adaptés.*
2. *Effectuez les gestes qui pourraient répondre à une hypothèse diagnostique que vous vous êtes posée.*
3. *Effectuez les gestes qui permettraient d'exclure une hypothèse diagnostique possible.*

En pratique, on peut faire une version « réduite » d'un geste qui pourrait prendre du temps, et approfondir si l'on remarque quelque chose de suspect. Pour prendre l'exemple de l'examen de sensibilité au status neurologique, il n'est pas nécessaire d'évaluer chaque dermatome un à un. En effet, stimuler les dermatomes en passant les mains rapidement sur chaque zone tout en demandant au patient s'il sent quelque chose d'anormal est suffisant *pour autant* qu'il n'y ait pas d'anormalité ou que l'anamnèse ne demande pas à approfondir cet aspect. En règle générale, n'hésitez pas à effectuer les gestes peux « coûteux » en temps, mais choisissez bien ceux qui prennent du temps et n'hésitez pas à en faire une version « réduite » pour commencer

Comme pour l'anamnèse, évitez absolument « l'appris par cœur » qui ne vous aidera pas. Il faut être **systématique mais pas automatique**. Il faut savoir raisonner et *surtout* que chaque geste que vous effectuiez fasse sens dans le contexte, soit pour pousser vers un diagnostic, soit pour en exclure un autre.

A l'ECOS, pour ne pas perdre de précieuses minutes, il arrive que l'expert dise « **le status est normal, passez** » si vous débutez un status qui n'est pas indiqué dans la vignette clinique.

3. **Management :**

Cette section peut être divisée en plusieurs aspects :

- a. Demande et analyse de tests paracliniques
- b. Evocation d'une ou de plusieurs hypothèses diagnostiques (diagnostic différentiel)
- c. Proposition de prise en charge
- d. Traitement(s)

a. **Demande et analyse de tests paracliniques :**

Voici une liste d'exemples de tests (non exhaustive) que vous pourriez être amenés à demander :

- ECG
- Laboratoires : formule sanguine simple / complète (FSS/FSC), chimie sanguine, tests spécifiques (p.ex : de grossesse, dipstick urinaire etc.).
- Radiographies
- Biopsies

Cette section est celle qui diffère le plus à l'ECOS par rapport à la pratique réelle. Effectivement, à l'ECOS, si le test que vous avez demandé est disponible, il vous sera tendu directement (sur une carte / image sur un Ipad) et vous devrez l'analyser. Dans la pratique clinique, rien n'est instantané. Vous avez généralement le temps d'aller consulter vos chefs et la littérature mais aussi de demander de nouveaux tests plus tard. Ce n'est pas le cas à l'ECOS !

b. **Evocation d'un diagnostic différentiel** : cet aspect joue aussi avec la limite des différences entre la clinique et l'ECOS. En clinique, vous allez rarement faire une liste des maladies potentielles que votre patient pourrait avoir directement devant lui, tandis qu'à l'ECOS cela peut vous permettre de transmettre vos conclusions diagnostiques à l'expert d'une façon détournée. Une bonne tactique pour effectuer cette tâche tout en restant dans le « jeu » de l'ECOS est d'expliquer à votre patient les diverses possibilités diagnostiques qui sont possibles en restant autant que possible hors du jargon médical (on ne dira pas par exemple « je pense que vous avez une endocardite » mais « il est possible que vous ayez une infection au cœur, c'est ce qu'on appelle une endocardite »). L'expert comprendra où vous voulez en venir, et s'il souhaite des précisions techniques, il vous posera la question directement. Quoiqu'il en soit, trouver le bon diagnostic vaut rarement plus qu'un point sur le total, ne vous fixez donc pas trop là dessus !

c. **Prise en charge** : à la fin d'un entretien, autant en clinique qu'à l'ECOS, vous devez être en mesure d'évoquer la suite de la prise en charge après l'entretien. Va-t-on hospitaliser le patient ? Doit-il subir d'autres tests avant de pouvoir rentrer ? Souhaitez vous le revoir en consultation et dans quels délais ? Cet aspect est important autant pour montrer que vous maîtrisez le sujet que pour faire preuve d'empathie. En effet, un patient qui sort de l'entretien en n'ayant rien compris de la suite des événements n'est pas un patient content. Si vous ne *savez pas* quelle est la suite de la prise en charge, n'hésitez pas à le dire ! Vous pouvez par exemple dire « j'aimerais d'abord consulter mon supérieur puis je reviens vers vous d'ici quelques instants ». On n'attend pas de vous que vous sachiez tout faire, simplement que vous fassiez preuve que vous avez compris que la situation ne s'arrête pas au moment où vous sortez de la chambre.

d. **Traitements** : de manière générale, aucun traitement ne vous est demandé à ce stade **sauf** s'il s'agit d'une situation urgente. Tous les malaises/syncopes/comas/chocs demandent un traitement rapide et vous devez être en mesure d'assurer les bases.

4. **Conclusion de l'entretien** : une fois toutes les étapes précédentes effectuées, il convient de conclure l'entretien en résumant la situation et la prise en charge que vous proposez. Parallèlement, vous devez vous enquérir des questions résiduelles que le patient pourrait avoir. Après tout cela, vous pouvez prendre congé de votre patient.

Mot de la fin : oui, vous devez faire tout cela en 13 minutes top chrono. C'est impossible de *tout* faire dans le temps imparti. La capacité à être systématique et ciblé est la clef d'un bon entretien. A l'ECOS, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez revenir dans la pièce même après être partis.

Status ophtalmologique

1. Examen externe de l'œil et de ses annexes : éverser les paupières et faire varier le regard pour voir tout l'œil.
2. Eversion de la paupière supérieure (eg. suspicion de CE) : pincer les cils et éverser la paupière en s'aidant d'un coton-tige, observer.
3. Examen du champ visuel :
 → Un œil après l'autre (couvrir œil non-utilisé)
 - a. **Quadrants** : tests des chiffres (doigts de la main) dans les 4 quadrants.
 - b. **Périphérie** : bouger doigts depuis derrière et se rapprocher du champ visuel du patient. Noter quand le patient aperçoit le mouvement.
4. Oculomotricité :
 - a. **Fixation oculaire** : demander au patient d'observer un objet pendant 10-15 secondes et observer si la fixation est stable ou au contraire interrompue par des saccades.
 - b. **Poursuite oculaire** :
 - i. *Poursuite horizontale* : demander au patient de suivre le doigt, effectuer un mouvement horizontal prévisible. Aux extrémités, noter s'il y a la présence d'un nystagmus.
 - ii. *Poursuite verticale* : même principe, mais on tient les paupières supérieures pour éviter qu'elles ne recouvrent l'œil durant la poursuite inférieure.
 - c. **Mouvements de saccade** : faire le test « doigt-nez », le patient doit alternativement regarder le nez ou le doigt qu'on positionne de manière fixe dans les 4 directions (toujours tenir paupières supérieures quand on observe le regard inférieur). La saccade est normale si elle est rapide et précise, sans hésitation.
 - d. **Convergence** : approcher un doigt du patient de manière à le faire loucher. Le doigt ne doit pas suivre une ligne droite mais varier dans sa trajectoire.
 - e. **Examen des muscles oculomoteurs** : demander au patient de regarder à droite, gauche, en haut, en bas, et les 4 diagonales. Ne pas oublier de tenir les paupières sup. dans l'inspection des regards inférieurs.
5. Réflexe pupillaire :
 - a. **Diamètre des pupilles** : identique ? Si oui = isocore, sinon anisocorie.
 - b. **Réflexe photomoteur à la lumière** : réflexe direct et consensuel et test de la lumière alternante (→ dilatation pupillaire paradoxale en cas de neuropathie optique afférente)
 - c. **Réflexe à la convergence** : le test de la convergence induit un myosis bilatéral.
6. Acuité visuelle :
 → Faire chaque œil en alternance. Si le patient a des lunettes, il peut les utiliser.
 - a. **Proche** : carte de lecture, tenir la carte à 40 cm du patient.
 - b. **Loin** : utiliser le tableau
7. Vision des couleurs : utiliser le livre spécial, chaque œil en alternance
8. Ophtalmoscopie directe : observer l'œil droit du patient en tenant l'ophtalmoscope de la main droite et en utilisant son œil droit. On commence un peu loin du patient et un peut latéralement en focalisant la lumière vers la pupille puis on se rapproche en tenant la paupière supérieure. La même chose mais inversé pour l'œil gauche.

Status neurologique

1. Etat mental (status psy) :
 - a. **Niveau de conscience** : vigilance ou état de perception de l'environnement.
 - b. **Attention** : capacité à se concentrer un certain temps sur une tâche/activité
 - c. **Mémoire** : série de mots
 - d. **Orientation** : identité, temps, espace
 - e. **Perception** : hallucinations visuelles/auditives/sensorielles
 - f. **Processus de la pensée** : logique, cohérence, pertinence de la pensée
 - g. **Compréhension intuitive (insight)** : conscience que ses troubles du comportement sont normaux/anormaux
 - h. **Jugement** : processus de comparaison et d'évaluation des alternatives. Reflet de valeurs qui peuvent être fondées *ou non* sur la réalité/conventions sociales/normes.
 - i. **Affect** : tonalité émotionnelle, observable par la voix/mimique/comportement
 - j. **Humeur** : état émotionnel (plus durable que l'affect), qui *colore* la vision du monde qu'a une personne (l'humeur est à l'affect ce que le climat est au temps).
 - k. **Langage** : système complexe d'expression/réception/compréhension de mots.
 - l. **Fonctions cognitives supérieures** : vocabulaire, culture générale, pensée abstraite, calcul etc.
2. Nerfs crâniens :
 - a. Votre odorat ou voix se sont-ils modifiés ces derniers temps ? (I & X)
 - b. Avez-vous des troubles pour avaler ? (IX)
 - c. Champ optique avec chiffre et test des périphéries (II)
 - d. Réflexe photomoteur pupillaire, direct, consensuel et alternant (II, III)
 - e. Examen de poursuite oculaire (III, IV, VI)
 - f. Sensibilité de la face (V)
 - g. Froncer les sourcils, fermer les yeux, gonfler les joues (VII)
 - h. Ouvrir la bouche, observer uvula et motricité langue (X, XII)
 - i. Se placer derrière le patient et faire des bruits $\pm$ Rinné-Weber (VIII)
 - j. Bouger tête gauche-droite, soulever épaules (XI)
3. Force & sensibilité :
 - a. Sensibilité grossière des membres supérieurs et inférieurs
 - b. Force des membres supérieurs et inférieurs : force grossière, serrer les mains, écarter les doigts, opposition du pouce, pianotage
 - c. Tonus (à rechercher ++ dans le mouvement de l'épaule et du coude)
 - d. Tests de palesthésie
 - e. Touché-piqué
 - f. Proprioception : tenir doigt latéralement et fermer les yeux, Romberg, touché son nez avec les yeux fermés.
 - g. Schober : toucher sol avec doigts (canal lombaire étroit)
 - h. $\pm$ Test calorique
4. Réflexes (Cotation normale = +2) :
 - a. Bicipital (C5, C6)
 - b. Tricipital (C6, C7)
 - c. Styloradial (C5, C6)
 - d. Abdominaux (T8, T9, T10, T11, T12)
 - e. Rotulien : (L2, L3, L4)
 - f. Achilléen (S1)
 - g. Babinski (L5, S1)
5. Cérébelleux :
 - a. Romberg (= proprioception $\neq$ cérébelleux)
 - b. Marche du funambule / talon / pointe
 - c. Marionnettes / coordination
 - d. Doigt-nez & Talon-Genou
 - e. Marche militaire & saut monopodal

Status ORL

→ Se placer en face du patient avec ses jambes de part et d'autre du patient.

1. Palpation cervicale :

- Palpation antérieure au muscle sterno-cléido-mastoïdien (SCM).
- Inclinaison de la tête pour la palpation du SCM (chaines jugulaires et spinales)
- Chaines sous-mandibulaire et sous-mentonnières
- Chaines spinales et sus-claviculaires

2. Examen de la bouche :

- Lampe frontale** : ajuster pour que la lumière corresponde au regard
- Ouverture buccale ≥ 35 mm
- Mobilité de la langue
- Observation des orifices des canaux de **Warton** et veines sublinguales au niveau du plancher de la bouche
- Abaisse langue** : se tient comme un crayon entre le pouce et le majeur
- Évaluation de l'état dentaire et parodontal dans les 4 quadrants à l'aide de l'abaisse-langue + observation des orifices des canaux de Stenon (drainage parotide)
- Abaissier la langue pour observer l'uvula et l'oropharynx. En abaissant latéralement on observe les amygdales palatines jusqu'au sillon amygdaloglosse.
- Test de la contraction et la mobilité du voile du palais en demandant au patient de dire « Aaah ».
- Pour terminer, en s'aidant d'un 2^{ème} abaisse-langue, on observe l'espace retro-molaire et le sillon gingivo-glosse dans sa totalité

3. Laryngoscopie indirecte :

- Saisir la langue entre le pouce et le majeur de la main gauche à l'aide de **compressees**. L'index tient la bouche ouverte
- On préchauffe le miroir angulé, teste sa température sur la main, puis on l'insère dans la bouche parallèle à la langue. On visualise successivement la base de langue, l'épiglotte et les valécules.
- Un « **iiii** » relève le pharynx et expose les cordes vocales. On observe postérieurement la margelle laryngée, les aryténoïdes et de part et d'autre les sinus piriformes.

4. Examen du nez :

- Observation du vestibule en relevant la pointe du nez. On observe la présence d'une déviation septale antérieure.
- Test de la perméabilité nasale en objectivant la condensation sur un miroir
- Rhinoscopie antérieur** : utilisation du spéculum de Killian (écarteur). L'introduire dans le nez en maintenant l'index sur le nez pour la stabilité. Observer le cornet inférieur, le méat inférieur. Retirer le spéculum *sans* le refermer.

→ On peut utiliser le spéculum de Vacher qui utilise un pas-de-vis pour la dilatation nasale.

5. Rhinoscopie postérieure indirecte :

- Utilisation du miroir de Michel
- Le patient respire par le nez
- On utilise l'abaisse langue et on préchauffe le miroir et on le teste sur le dos de la main. On passe l'uvula en demandant au patient de faire « HA » puis on angule progressivement le miroir. Ceci nous permet d'observer le septum et muqueuse septale postérieurs et latéralement le bourrelet tubaire et la fossette de Rosenmüller.

6. Examen des oreilles :

- Débuter par l'examen osseux périauriculaire
- Percuter la pointe de la mastoïde en réclinant le pavillon de l'oreille à la recherche d'une douleur
- Otoscopie** : tenir l'otoscope comme un crayon (main droite pour oreille droite et inversement, incliner la tête du patient et tirer l'oreille avec 3 doigts vers derrière et vers le haut. Terminer par le test de Valsalva pour évaluer la perméabilité du tympan.

→ Chaque outil utilisé est mis de côté sur le 2^{ème} étage de la table à outil

Status orthopédique

Examen de l'épaule :

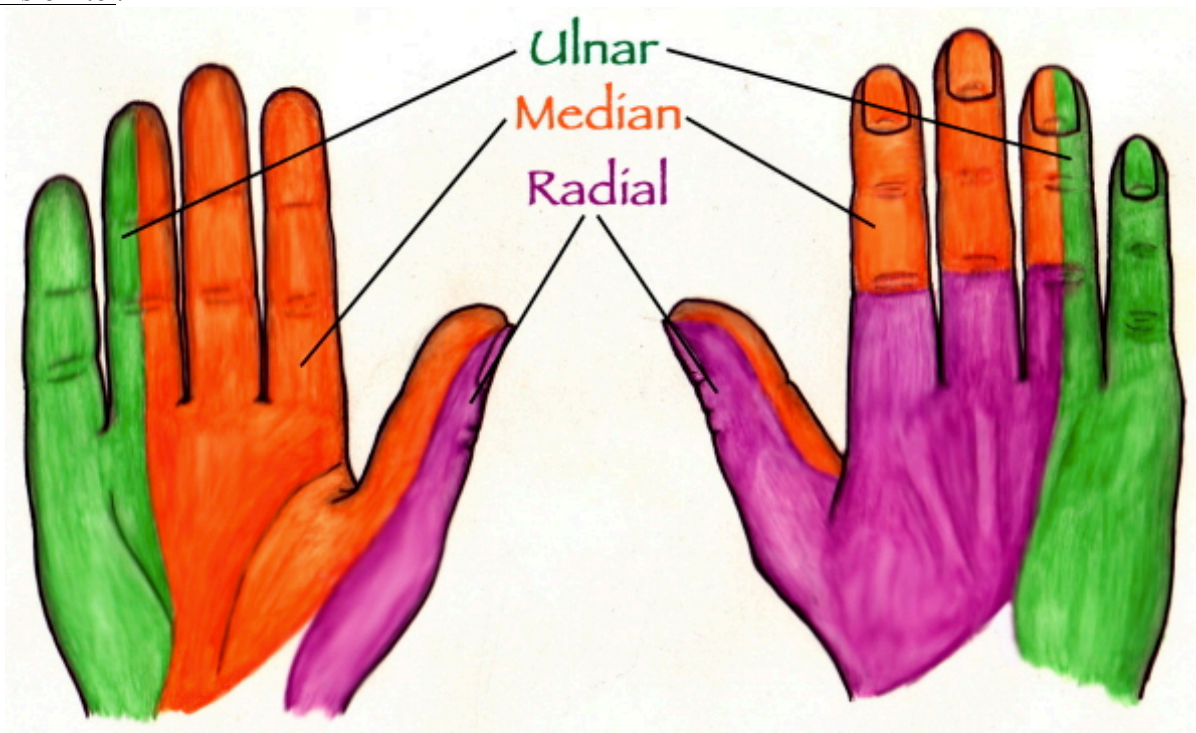
1. Observation : déformation, asymétrie, gonflement, rougeur, trophicité → regarder devant, derrière, latéralement et *par-dessus* !
2. Palpation :
 - a. Articulation sternoclaviculaire : sensibilité, dislocation
 - b. Clavicule
 - c. Articulation acromio-claviculaire : sensibilité, dislocation
 - d. Processus coracoïde
 - e. Articulation huméro-scapulaire
3. Mouvement (passif et actif) :
 - a. Extension et flexion
 - b. Abduction et adduction
 - c. Rotation externe et interne (belly press, lift off)
 - d. Main derrière le dos touchant la scapula controlatérale
4. Neuro : réflexes et sensibilité
5. Coiffe des rotateurs :
 - a. **Mouvement de rotation externe contre résistance** : mm. petit rond et infra-épineux
 - b. **Mouvement de rotation interne contre résistance** : m. sous-scapulaire (lift-off marche aussi, si incapable de le faire → probable déchirure du sous-scapulaire)
 - c. **Test de Jobe (empty can test)** : m. supra-épineux
<https://www.youtube.com/watch?v=yMUKK8SgiXs>
 - d. **Test de Neer** : extension du bras tendu en pinçant l'articulation. Si cela provoque une douleur, parle pour un impingement (= tendinite/boursite de la CdR).
https://www.youtube.com/watch?v=U8-yLHQ_JaM
 - e. **Test de Hawking** : abduction du bras à 90° avec coude fléchi. Si la rotation interne déclenche une douleur, parle pour un « impingement syndrome ».
<https://www.youtube.com/watch?v=OYK5qL2om-c>
6. Tests de stabilité :
 - a. Test de laxité des doigts de la main et des épaules
 - b. **Test du sulcus** : en cas d'instabilité postérieure, une traction du bras vers le bas en position relâchée crée une « vallée » ou « sulcus ».
 - c. **Load and shift test** : on tient la scapula et on bouge l'épaule antérieurement et postérieurement pour évaluer la laxité de l'articulation.
<https://www.youtube.com/watch?v=txARar7lh5E>
 - d. **Test d'appréhension antérieure** : similaire au load and shift. On effectue une abduction à 90° du bras et on pousse avec le pouce antérieurement sur l'articulation.
https://www.youtube.com/watch?v=_JA-qvXcUdQ

Examen du poignet :

1. Observation : gonflement, discoloration, mauvais alignement.
2. Palpation : ne pas oublier palpation de la tabatière anatomique (fracture scaphoïde) et test du piston.
3. Mouvement et stabilité : y.c. test du pouce du skieur
4. Status distal : mouvement actif des doigts, circulation (pulse, temps de recoloration), sensibilité
5. Syndrome du tunnel carpien :
 - a. **Signe de Tinel** : percussion du tunnel carpien provoque des paresthésies
 - b. **Signe de Phalen** : = test de la prière inversée (flexion max du poignet). Il faut le tenir *minimum 30 secondes* avant d'arrêter et dire que le test est négatif.
<https://www.youtube.com/watch?v=DZ9UGuA8oAE>

Examen de la main :

1. Observation :
 - a. Gonflement, discoloration, malalignement, ongles, taille des doigts
 - b. Malalignement lors de la flexion des doigts
2. Palpation : y.c. tabatière anatomique et test du piston
3. Vasculaire : pouls, temps de recoloration
4. Mouvement :
 - a. Tester globalement tous les mouvements
 - b. **Opposition du pouce**
 - c. **Flexeurs profonds** : tenir les doigts à la phalange moyenne et demander de fléchir
 - d. **Flexeurs superficiels** : tenir tous les doigts en extension sauf celui que l'on teste.
5. Force :
 - a. **Radial** : extension des doigts et du poignet (signe de l'autostoppeur)
 - b. **Ulnaire** : abduction et adduction des doigts (signe « peace »)
 - c. **Médian** : abduction et opposition du pouce (signe « ok »)
6. Sensibilité :



Examen de la hanche :

1. Observation :
 - a. Marche, asymétrie, Trendelenburg
 - b. **Couché** :
 - i. Jambe raccourcie et en rotation externe ? Probablement fracture
 - ii. Jambe raccourcie et en rotation interne ? Probablement dislocation
2. Palpation : pelvis, pubis, grand trochanter
3. Mouvement : flexion, extension, rotation interne et externe (cave : contre-intuitif)
4. Force : tester tous les mouvements contre résistance. Selon mm. atteint, on peut mettre le patient y.c. sur le ventre.

Examen du genou :

1. Observation :
 - a. **Debout** : varus ($\angle$), valgus ($\angle$), kyste de Baker (post.), ganglions, marche
 - b. **Décubitus dorsal** : atrophie musculaire, gonflement discoloration
2. Palpation :
 - a. Interligne articulaire
 - b. Signe du glaçon
 - c. Ligaments collatéraux
 - d. Test d'appréhension patellaire (genou fléchi 10-20°)
 - e. Insertion des tendons patellaires
3. Mouvement :
 - a. Extension (N=0°),
 - b. Flexion (N=135-140°)
4. Stabilité :
 - a. **Ligaments collatéraux** : provoquer une force en valgus (lig. interne) ou varus (lig. externe) avec un genou fléchi à environ 20°
 - b. **Ligaments croisés** :
 - i. *Tiroirs* antérieur et postérieur (s'asseoir sur pied), genou 90° fléchi
 - ii. *Lachmann* : similaire au tiroir, mais flexion genou 20°.
 - iii. *Pivot-shift* : jambe tendue, exercer une rotation puis fléchir le genou
5. Tests méniscaux :
 - a. **Compression d'Apley** : patient en décubitus ventral, flexion de 90° des genoux. Compression de l'articulation en même temps qu'effectuer une manœuvre de rotation.
<https://www.youtube.com/watch?v=At0FdkHaCGo>
 - b. **McMurray** : eg. pour le ménisque interne → le mettre en pression (effectuer un varus forcé), puis fléchir le genou complètement et effectuer une rotation externe de la hanche. Si on sent un « clic » ou entend un « pop » à l'extension du genou, le test est positif.
<https://www.youtube.com/watch?v=Irg3Cb4JaE8>

Examen de la cheville :

1. Inspection : asymétrie, gonflement, discoloration
2. Palpation : tout palper
3. Mouvement : dorsiflexion normale = 20°, flexion plantaire normale = 50°.
4. Stabilité
5. Tendons d'Achille :
 - a. Observation/palpation (pied tombant)
 - b. **Test de Thompson** : patient en décubitus ventral, les pieds dépassant du lit, une absence de flexion plantaire à la compression des muscles de la cheville est un test positif.
<https://www.youtube.com/watch?v=QTSRpt12wK4>

Examen du dos :

A) Debout :

1. Observation :
 - a. S'habiller/se déshabiller
 - b. Marche
 - c. Symétrie, lordose, cyphose, scoliose
 - d. Position du Pelvis
2. Palpation :
 - a. Processus épineux
 - b. Muscles paravertébraux
 - c. Articulations sacro-iliaques
 - d. Mm. glutéaux
3. Mouvement :
 - a. Flexion du dos (toucher le sol avec les mains) / extension
 - b. Flexion de côté avec mains sur hanches
 - c. Rotation avec pelvis fixé
 - d. Marche sur orteils (S1), marche sur talon (L4-L5), Gowers (L4)

B) Couché

1. Palpation : pelvis, articulations, abdomen
2. Neurologique :
 - a. *Sensibilité* :
 - i. L4 : cuisse antérieur, pied médial
 - ii. L5 : jambe latérale, pied postérieur jusqu'à l'hallux
 - iii. S1 : face dorsale du pied, face latérale du pied
 - iv. S2-4 (queue de cheval) : sensibilité périnéale
 - b. *Réflexes* :
 - i. L1-2 : crémaster
 - ii. L4-5 : patellaire
 - iii. S1 : Achilléen
 - iv. S2-4 : bulbo-caverneux
 - c. *Forces musculaires* :
 - i. Quadriceps : L2-3-4
 - ii. Tibial antérieur : L4-5
 - iii. Flexion plantaire : S1
 - iv. Tonus sphinctérien (queue de cheval) : S2-3-4
 - d. Lasègue direct et croisé (straight leg raise test)
3. Vasculaire : pouls poplitée, pédieux et tibial postérieur – claudication vasculaire ?

Status cardio-pulmonaire :

1. Observation :
 - a. Extrémités (ongles, nodules, lésions)
 - b. Cyanose (centrale vs périphérique)
 - c. Œdèmes
 - d. Varices
 - e. Turgescence jugulaire
2. Palpation :
 - a. Ganglions
 - b. Pouls aux extrémités
 - c. Temps de recoloration
 - d. Choc de pointe
 - e. Œdèmes
 - f. Reflux hépato-jugulaire
 - g. Amplitude respiratoire
3. Auscultation
 - a. **Cardiaque** : 4 foyer valvulaires + carotides
 - b. **Pulmonaire** : plages postérieures, latérales et antérieures
 - c. **Test du « 33 »** (faire dire 33 à haute voix au patient pour tester la transmission des vibrations)
4. Percussion pulmonaire

Status abdominal :

→ Le praticien se place à droite du patient

1. Observation : symétrie, voussures, cicatrices, caput medusae, ascite
2. Auscultation : borborygmes dans les 4 quadrants
3. Percussion : zone d'hypertympanisme/matité ? Taille du foie/rate ?
4. Palpation superficielle (1 main) : péritonisme ?
5. Palpation profonde (2 mains) :
 - a. Foie
 - b. Rate
 - c. Aorte (ne pas oublier pouls fémoraux)
 - d. Reins
6. Tests spécifiques :
 - a. **Appendicite** : McBurney, Psoas (= soulever jambe contre force ≠ Lasègue), Rosving
 - b. **Cholécystite** : Murphy
 - c. **Ascite** : glaçon, flot
7. Palpation des hernies : inguinales, ombilicale, ligne blanche
8. Toucher rectal : palpation prostate, douleur, observation de sang.

Status du sein :

1. Anamnèse :

- a. Recueillir la plainte de la patiente
- b. Cerner la plainte : depuis quand, quand la première fois, description (boule, rougeur, écoulement, sensibilité, ulcération), relation avec le cycle menstruel, localisation, évolution, écoulement (eg. tâche sur les habits), ttt déjà instauré, autres médicaments, antécédents de lésion du sein, antécédent de tumeur, anamnèse familiale.

2. Inspection :

- a. Observer la cage thoracique : thorax en carène, séquelles d'accidents
- b. Symétrie et morphologie :
 - i. Mamelon supplémentaire (polythélie) / polymastie (sein supplémentaire)
 - ii. Inspection verticale (bord du lit ou debout), s'asseoir face à elle. Bras le long du corps.
 - iii. Comparaison des deux seins (symétrie). Cave : jamais complètement symétrique
 - iv. Lésions nouvelles : rétractions, bosses, voussures
- c. Inspection de la peau : couleur, texture, la présence de cicatrice/ecchymose, réseau veineux, naevus, mamelon surnuméraire, peau d'orange (lymphœdème cutané)
- d. Mamelons et aréole (variation ethnique importante) : couleur, asymétrie, rétraction fixée / rétractile, déformation (élargissement), écoulement.
 ➔ Signes suspects de lésion maligne : rétraction d'apparition *récente*, écoulement *unilatéral*
- e. Mobilité : inspection des seins lorsque la patiente soulève les bras avec mains derrière la tête. Bien observer si des déformations / rétractions / voussures se présentent durant le mouvement.
- f. Inspection sous traction musculaire (mains sur les hanches) : peut mettre en évidence d'autres déformations.
- g. Inspection en position couchée : observation particulière des quadrants inférieurs, mieux visibles.

3. Palpation :

- a. *Position verticale* : diviser le sein en 4 quadrants, utiliser la pulpe de 3 doigts pour palper. Effectuer des lignes verticales parallèles du haut vers en bas en partant de la clavicule pour palper les quadrants supérieurs. Aller de la gauche vers la droite.
 ➔ 60% des tumeurs malignes se trouvent dans le quadrant supéro-externe (prolongement axillaire inclus)
- b. *Position couchée* : idéal pour la palpation des quadrants inférieurs. Bien palper toute la région, jusqu'à 1 cm sous le pli mammaire.
- c. *Recherche d'écoulement* : pincer le mamelon de la patiente entre le pouce et l'index. Prévenir la patiente ou mieux lui demander de le faire elle-même. Un écoulement n'est associé que dans 8% des cas à une pathologie maligne. La plupart du temps le problème est bénin (eg. papillome canalaire).

4. Ganglions :

- a. Inspection
- b. Palpation périclaviculaires & SCM. Palper toute la région entre la clavicule, le sein et le sternum
- c. Palpation axillaire : demander à la patiente de mettre sa main sur votre épaule pour détendre les muscles et palper toute la région axillaire en commençant par devant. On peut aussi mettre la patiente avec ses mains sur les hanches.
- d. Palpation couchée

Status gynécologique :

→ En cas de grossesse, l'examen doit se faire de manière stérile

1. Préparation du matériel
2. Inspection et palpation de l'abdomen
3. Positionnement de la patiente : fesse dépassant légèrement de la chaise (le poids doit être partagé entre sacrum et colonne lombaire de manière à effacer la lordose lombaire et aligner l'axe du vagin avec celui de la vision), jambes posées contre les cals (détendues) et bras le long du corps
4. Inspection des organes génitaux externes :
 - a. Mettre les gants, informer la patiente du geste et mettre le dos de la main contre la cuisse pour voir si la patiente est détendue
 - b. Inspection générale : pilosité, et peau de la région pubienne/inguinal et du périnée.
 - c. Inspection de la vulve (Mont Vénus, Grandes/petites lèvres, clitoris et vestibule). Normalement symétrique. Chercher tumeur, tuméfaction ou ulcération. Contrôler la taille du clitoris.
 - d. Inspection du vestibule au repos : écarter manuellement les grandes lèvres (prévenir patiente
 - e. Inspection du vestibule sous pression abdominale : écarter les grandes lèvres vers la partie sacrale avec les deux mains. Demander à la patiente de pousser comme si elle allait à selles. Observer la présence d'un prolapsus ou hernie (urétrocèle, rectocèle etc.)
 - f. Inspection de la région anale (fissure, rougeur, hémorroïdes etc.)
5. Palpation des glandes : palper les glandes de Bartholin avec l'insertion de l'index dans la cavité vaginale et la compression des glandes entre le pouce et l'index.
6. Examen au spéculum :
 - a. *Matériel* : spéculum, lubrifiant (K-Y), gants
 - b. *Mise en place du spéculum* :
 - i. Ecarter les lèvres avec la main libre en tirant vers le bas.
 - ii. Tourner le spéculum d'au moins 45° et l'apposer sur la commissure postérieure
 - iii. Tourner le spéculum durant l'insertion de manière à éviter au maximum les résistances et inconfort (éviter la zone antérieure, comme le clitoris et l'urètre, qui sont très sensibles).
 - iv. Ouvrir les valves à l'aide du manche en maintenant l'orientation vers le col. Fixer la vis à l'aide de l'écrou une fois que les valves ont atteint les culs-de-sac.
 - c. *Inspection du col* : position, axe, forme, diamètre, couleur, ouverture
 - d. *Frottis vaginal (eg. si écoulement)* : examen microscopique natif
 - i. Matériel : spatule, lame porte objet, lamelle d'observation, NaCl 0.9%, ± KOH 10% si suspicion de mycose.
 - ii. M-à-s : prélever du matériel dans le cul de sac vaginal à l'aide de la spatule, étendre le matériel récolté sur la lamelle (où est annoté l'identité et la date de naissance de la patiente), faire tomber une goutte de NaCl sur la lamelle (KOH si recherche de mycelle) et apposer une 2^{ème} lamelle.
 - e. Inspection du vagin en rétractant le spéculum : desserrer la vis puis regarder les parois du vagin en tournant le spéculum. Retirer doucement le spéculum *sans* le refermer.

7. Palpation vaginale bimanuelle :

- a. Introduction des doigts (index et majeur) : le praticien se tient debout, écarter légèrement les lèvres en tirant vers le bas, introduire les doigts (45° - plutôt vertical) puis les tourner en entrant en exerçant une pression sur la paroi postérieure du vagin. Les doigts visent le coccyx.
- b. Palpation du vagin : explorer toute la paroi à la recherche de nodules, cicatrices, douleurs. A la fin du vagin la main de l'examineur doit avoir fait un tour et se présenter paume vers le haut. Insérer ses doigts sous l'utérus, dans le cul-de-sac postérieur.
- c. Palpation du col : évaluer sa position (N= centré), consistance (eg. ramolli, friable, ferme), mobilité. La mobilisation de 2-4 cm dans toutes les directions est normale, en cas de douleur à la mobilisation, penser à une PID.
- d. Palpation de l'utérus et des annexes : = palpation bimanuelle à proprement dit, placer l'autre main sur l'abdomen et palper tour à tour l'utérus et les ovaires de chaque côté. Soulever le col avec la main qui se trouve dans le vagin et appuyer avec l'autre main pour la palpation. Apprécier la taille, la forme, la consistance et la mobilité des organes. Pour la palpation des ovaires, on placera la main vaginale dans le cul-de-sac vaginal latéral du côté correspondant.

8. Palpation recto-vaginale : partant de la palpation bimanuelle, retirer le majeur du vagin tout en y maintenant l'index. Introduire lentement le majeur dans le rectum en demandant en même temps à la patiente de pousser un peu. Bien palper la paroi recto-vaginale en cherchant d'éventuels nodules et en marquant si la patiente ressent un inconfort.

9. Palpation rectale : TR classique

Dermatologie :

Descriptions de lésions dermatologiques :

A) *Lésions primaires :*

- **Macule** : taches (différence de couleur) sans relief ni infiltration (eg. vasodilatation, altération pigmentaire)
- **Vésicules** : élevation circonscrite contenant une sérosité claire
- **Bulle** : vésicule de > 5 mm
- **Pustule** : élevation circonscrite contenant du pus
- **Papule** : élevation circonscrite *solide* (hyperplasie épidermique)
- **Nodule** : masse dermo-hypodermique *palpable*, avec ou sans élevation (> 5mm)

B) *Lésions secondaires :*

- **Squame/hyperkératose** : *desquamation* visible, avec ou sans augmentation de l'épaisseur de la couche cornée
- **Croûte** : *exsudat coagulé* à la surface de la peau (sérum, sang, pus)
- **Erosion** : perte de substance *très superficielle* (épiderme)
- **Excoriation** : perte de substance du derme superficiel
- **Ulcère** : perte de substance superficielle *et* profonde (épiderme et derme)
- **Sclérose** : rigidification anormale de la peau
- **Atrophie** : amincissement de la peau avec perte d'élasticité

Rapport sur l'état cutané :

- Localisation
- Taille de la lésion
- Arrangement et distribution des lésions (eg. groupée, suivant un dermatome etc.)
- Description des lésions élémentaires 1° ou 2°

Description type de certaines lésions :

A) *Virales :*

- **Herpès simplex** : vésicules groupées sur fond érythémateux
- **Eczéma herpeticum** : surinfection sévère d'une dermatite atopique provoquant des vésicules groupées sur une large superficie ($\pm$ atteinte oculaire) sur fond érythémateux.
- **Varicelle** : exanthème (= rash) maculo-papulo-pustuleux avec lésions à différents stades d'évolution. Typiquement disséminé avec atteinte de la tête et de la bouche (élanthème) et épargne palmaire.
- **Zona** : plaques érythémateuses couvertes de multiples vésiculaires, unilatérales et en bande, suivant un ou plusieurs *dermatomes* et s'arrêtant à la ligne médiane.
- **Verrue (HPV)** : papules fermes à surface papillomateuse et hyperkératosique. Surface piquetée de points noirâtres.
- **Condylome acuminé** (HPV 6,11 $\pm$ 16,18) : tumeurs blanchâtres à surface papillomateuse.
- **Molluscum contagiosum** (famille des pox virus) : papules hémisphériques solitaires ou multiples avec ombilication centrale.

B) *Bactérienne :*

- **Dermohypodermite bactérienne (HAS, *S. aureus*)** : plaques érythémateuses oedémateuses, *bien délimitées*, chaudes et douloureuses à la palpation (cave portes d'entrée : mycoses, érosions superficielles). → Ttt = pénicilline ou Augmentin (céphalosporine si résistance)
- **Impétigo (++) strep, pfs staph)** : pustules de petites ou grande taille, couverte de croûtes de miel
- **Folliculite** : pustules périfolliculaires
- **Furoncle** : infection périfolliculaire profonde se présentant d'abord comme un nodule induré puis formant un abcès fluctuant avec centre nécrotique
- **Borrélieuse (*borrelia burgdorferi* – tique)** : érythème bien délimité accentué en bordure. Croissance centrifuge. Morsure de tique parfois visible au centre.